

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Informe de Evaluación Neuropsicológica

Variante Profesional

PACIENTE

Isabella Restrepo Gómez

DOCUMENTO

TI 1012345678

FECHA DE NACIMIENTO

08/03/2017

EDAD

9a 2m

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria — 3° grado

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

20/05/2026

ORDEN N°

264497091

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV Colombia

ELABORADO POR

Ps. Mariana Castro Ruiz

Psicóloga · Magíster en Neuropsicología Clínica · Reg. C.C. 1.020.456.789 — T.P. 198765

Información Sociodemográfica

NOMBRE COMPLETO Isabella Restrepo Gómez		DOCUMENTO TI 1012345678	
FECHA DE NACIMIENTO 08/03/2017	EDAD 9a 2m		SEXO Femenino
ESCOLARIDAD Primaria — 3° grado	OCUPACIÓN Estudiante		LATERALIDAD Diestra
CIUDAD Bogotá D.C.	ACOMPañANTE Madre (Catalina Gómez, 38 años)		REMITE Dra. Liliana Díaz — Psiquiatría Infa...
EPS / ASEGURADOR Sura EPS	ORDEN N° 264497091		FECHA DE ATENCIÓN 20/05/2026

Motivo de Consulta

MOTIVO REFERIDO POR EL CONSULTANTE

Niña de 9 años remitida por psiquiatría infantil para evaluación neuropsicológica con el fin de precisar el perfil cognitivo y apoyar la definición diagnóstica ante sospecha de TDAH presentación combinada y dificultades de aprendizaje en lectoescritura. La madre refiere: «se distrae con todo, no termina las tareas y la profesora dice que va atrasada en lectura». Se solicita caracterización de atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas para orientar el plan de intervención y los apoyos escolares.

Antecedentes Médicos

Historia clínica relevante — todas las áreas se consignan aunque no se reporten

PATOLÓGICOS / MÉDICOS

Embarazo deseado, controlado. Parto a término (39 semanas) por cesárea. Sin hospitalizaciones relevantes. Desarrollo motor dentro de lo esperado (marcha a los 13 meses).

ALÉRGICOS

Rinitis alérgica estacional. Sin alergias medicamentosas conocidas.

SENSORIALES / MOTORES

Agudeza visual y auditiva normales (tamizajes escolares 2025). Coordinación motora gruesa adecuada; refiere torpeza en motricidad fina.

TÓXICOS

No reporta exposición a tóxicos.

PSIQUIÁTRICOS

Sin antecedentes psiquiátricos personales previos. Primera consulta de salud mental a los 8 años por inquietud motora.

TERAPÉUTICOS

Actualmente en terapia de lenguaje (fonoaudiología) desde marzo 2026.

FARMACOLÓGICOS

No recibe psicofármacos al momento de la evaluación.

TRAUMÁTICOS

Niega traumatismos craneoencefálicos.

PARACLÍNICOS

Hemograma y perfil tiroideo (abr-2026) dentro de límites normales.

QUIRÚRGICOS

Adenoidectomía a los 5 años, sin complicaciones.

FAMILIARES

Padre con antecedente de dificultades de aprendizaje en la infancia. Tío materno en tratamiento por TDAH. Madre con trastorno de ansiedad.

Historia Familiar, Social y Funcional

VIVE CON

Vive con ambos padres y un hermano menor (5 años). Núcleo familiar funcional; la madre es la cuidadora principal.

ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS (ABC)

Independiente para alimentación, higiene y vestido. Requiere supervisión para organizar materiales escolares y cumplir rutinas.

ESCOLAR / LABORAL

Cursa 3° de primaria en colegio bilingüe. Rendimiento aceptable en matemáticas, descendido en lectura y escritura. La docente reporta que se levanta del puesto y no termina las actividades en clase.

PATRÓN DE SUEÑO

Duerme ~9 horas. Dificultad para conciliar el sueño los días de colegio; sueño reparador los fines de semana.

PATRÓN DE ALIMENTACIÓN

Selectiva con verduras; apetito conservado. IMC en percentil normal.

COMPORTAMIENTO / ÁNIMO

Niña afectuosa y sociable. Tolerancia baja a la frustración ante tareas difíciles; episodios de llanto cuando no logra terminar a tiempo.

Pruebas Aplicadas

Protocolo: WISC-IV Colombia

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Comprensión	Comprensión Verbal	—
Conceptos con Dibujos	Razonamiento Perceptual	—
Matrices	Razonamiento Perceptual	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Números y Letras	Memoria de Trabajo	—

Prueba	Dominio	Dur.
Claves	Velocidad de Proceso	—
Búsqueda de símbolos	Velocidad de Proceso	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—

Observación Clínica

Apariencia, actitud y conducta durante la evaluación

OBSERVACIÓN GENERAL

Escolar que ingresa alerta, orientada en persona y espacio, con adecuada presentación. Establece contacto visual y rapport con facilidad. Durante la sesión se observa inquietud motora (mueve pies y manos, se levanta en dos ocasiones), latencias de respuesta variables y necesidad de redirección verbal frecuente. Colaboradora, se beneficia del refuerzo positivo. Lenguaje espontáneo fluido, articulación con leve dislalia residual.

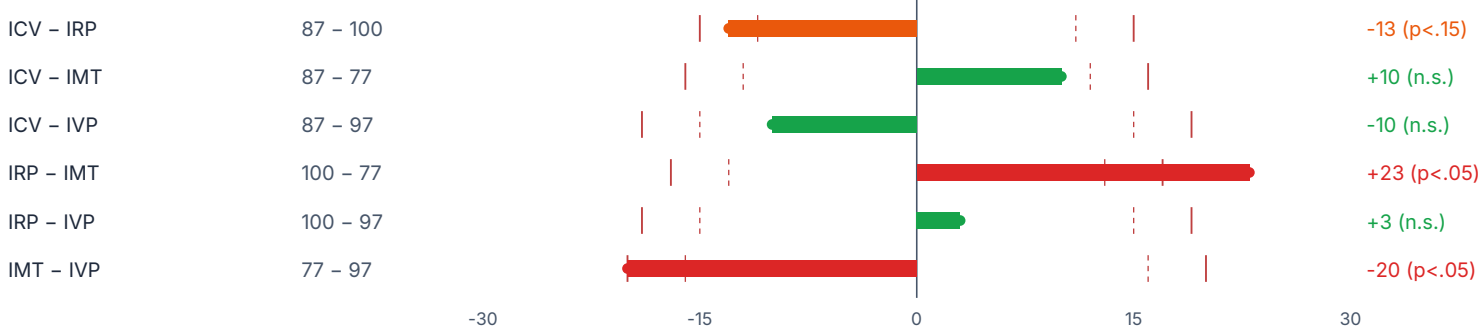
Resultados Cuantitativos

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Comp Verb 87 Promedio	Raz Perce 100 Promedio	Mem Trab 77 Limitrofe	Vel Proce 97 Promedio	CI total 88 Promedio
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Discrepancias entre índices

Líneas punteadas: tendencia ($p < .15$). Líneas continuas: diferencia confiable ($p < .05$). La barra central es la diferencia observada entre los dos índices.



Perfil Z por prueba

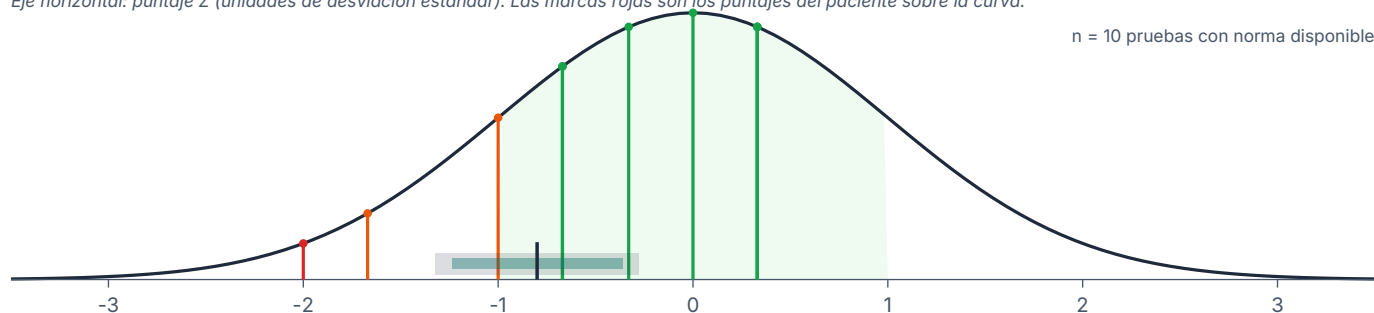
Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							+0.33
Semejanzas							+0.33
Vocabulario							-2.00
Comprensión							-0.67
Conceptos con Dibujos							-0.67
Matrices							+0.33
Regresión Dígitos Directos							-1.67
Números y Letras							-1.00
Claves							+0.00
Búsqueda de símbolos							-0.33
Ind Comp Verb							-0.87
Ind Raz Perce							+0.00
Ind Mem Trab							-1.53
Ind Vel Proce							-0.20
CI total							-0.80

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Curva normal con puntajes Z del paciente

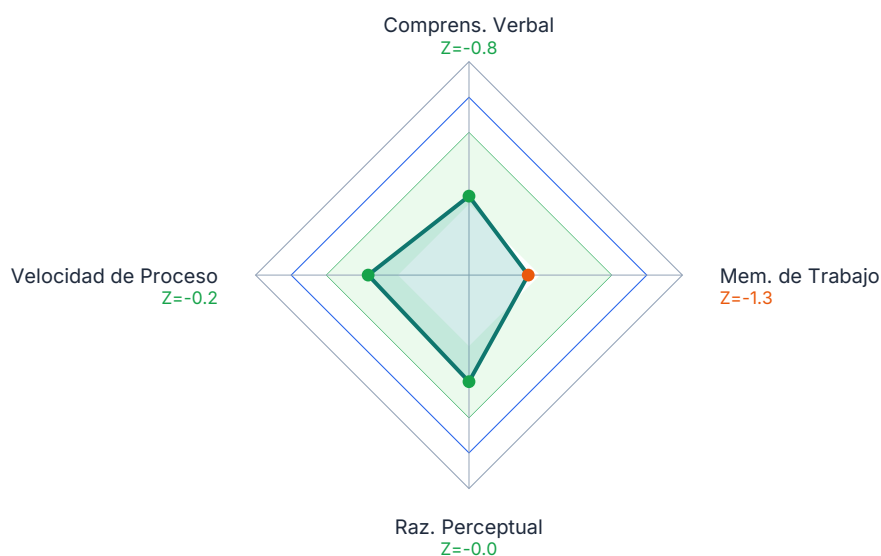
Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.



IC 95% [80-96] · IC 90% [81-95] · CIT observado: 88

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a $+1 \sigma$).



Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	30	11	+0.33	Promedio
Semejanzas	18	11	+0.33	Promedio
Vocabulario	14	4	-2.00	Bajo
Comprensión	16	8	-0.67	Promedio
Conceptos con Dibujos	14	8	-0.67	Promedio
Matrices	20	11	+0.33	Promedio
Regresión Dígitos Directos	9	5	-1.67	Límitrofe
Números y Letras	12	7	-1.00	Promedio
Claves	38	10	+0.00	Promedio
Búsqueda de símbolos	18	9	-0.33	Promedio
Ind Comp Verb	23	87	-0.87	Promedio
Ind Raz Perce	30	100	+0.00	Promedio
Ind Mem Trab	12	77	-1.53	Límitrofe
Ind Vel Proce	19	97	-0.20	Promedio
CI total	84	88	-0.80	Promedio

Análisis por Dominio

Lectura clínica de cada dominio a partir de los puntajes

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Atención sostenida disminuida: comete omisiones en tareas largas y su rendimiento decae con el tiempo en el puesto. La atención selectiva mejora con consignas cortas y apoyo visual. Memoria de trabajo límite (IMT=77), lo que repercute en el seguimiento de instrucciones de varios pasos.

PRAXIAS Y GNOSIAS

Praxias constructivas adecuadas (Diseño con Cubos PE=11). Gnosias visuales conservadas. Razonamiento perceptual en rango promedio (IRP=100). Leve torpeza en grafomotricidad.

FUNCIONES EJECUTIVAS

Dificultades en autorregulación, planificación y memoria de trabajo. Requiere apoyo externo para inhibir respuestas impulsivas y organizar la tarea. Se beneficia de la segmentación de actividades.

MEMORIA Y APRENDIZAJE

Memoria de reconocimiento conservada. La memoria de trabajo es el componente más afectado del perfil (IMT=77, límite), con descenso marcado en Retención de Dígitos.

LENGUAJE

Vocabulario expresivo por debajo de lo esperado para la edad (Vocabulario PE=4, bajo), con comprensión preservada. El índice de comprensión verbal (ICV=87) queda en promedio bajo. Persiste dislalia leve en abordaje fonoaudiológico.

EMOCIONES Y COMPORTAMIENTO

Ansiedad anticipatoria ante tareas evaluativas y baja tolerancia a la frustración. Sin indicadores de sintomatología depresiva.

COCIENTE INTELECTUAL

CI Total = 88 (promedio bajo), con perfil heterogéneo: IRP=100 (más alto) frente a IMT=77 (más bajo). La puntuación global no captura la variabilidad intraindividual, por lo que conviene interpretar por índices más que por el CIT.

FUNCIONALIDAD / AVD

Funcionalidad preservada para la vida diaria; el impacto se concentra en el desempeño escolar (lectura, completar tareas, organización).

Impresión Diagnóstica

Conclusión clínica · CIE-10 / DSM-5

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F90.0 · Trastorno de la actividad y de la atención (TDAH presentación combinada)

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA DEL PROFESIONAL

Perfil neuropsicológico compatible con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), presentación combinada (CIE-10 F90.0), con afectación de la atención sostenida, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, en el contexto de un funcionamiento intelectual promedio bajo (CIT=88). Coexisten una dificultad específica del lenguaje expresivo y rasgos de ansiedad anticipatoria. Se recomienda integrar estos hallazgos con la valoración psiquiátrica para la confirmación diagnóstica y la definición del manejo farmacológico, si procede.

Recomendaciones

Plan de manejo formulado por el profesional

Escolar

- Implementar apoyos en el aula: ubicación cercana al docente, instrucciones cortas y fraccionadas, tiempo adicional en evaluaciones y verificación de la agenda de tareas.
- Plan de apoyo en lectoescritura con refuerzo individualizado y material multisensorial.

Familiar

- Psicoeducación a padres sobre TDAH y pautas de manejo conductual en casa (rutinas, refuerzo positivo, economía de fichas).

Médica

- Continuar seguimiento por psiquiatría infantil para definir manejo farmacológico del TDAH según evolución.

Seguimiento

- Reevaluación neuropsicológica en 12 meses para monitorear respuesta a la intervención.

Terapéutica

- Iniciar entrenamiento en funciones ejecutivas y autorregulación (técnicas de organización, autoinstrucciones).
- Continuar fonoaudiología enfocada en lenguaje expresivo y dislalia residual.